



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : هنيه عباس سالم عفله

المحافظة : القليوبية الحي / المدينة : القناطر الخيرية العنوان :

رقم البطاقة : 25505161400865 رقم التليفون : 01067010668 تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 16-05-1955 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي :
التوقيع : (.....)

المقرر بما فيه :
التوقيع : (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر والحوض
بالصبغة [11127]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان

الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :

التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / / د. / / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :

قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

Name: هنيه عباس سالم غفله
National ID: 25505161400865



تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ وساعة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ وساعة الدخول :
-- --:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT Chest & abdomen and pelvis

الوقت :

-- --:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين



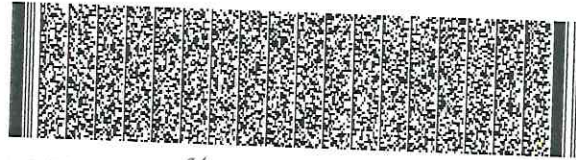
٢٠٢١/٠٤ ٢٥٥.٥١٦١٤.٠٠٨٦٥

ربة منزل



أنثى مسلمة متروجة
سيد محمد ابوريد عبدالرحيم
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٤/١٦

١١



١٠٦٧٠١٠٦٦٨
١٢٠٨٩٨٥٥٢٥

جمهورية فلسطين العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



هنيه

عباس سالم عقله

عزبة الشواربي

مركز القناطر الخيرية - القنوية

١٩٥٥/٠٣/١٦

٢٥٥.٥١٦١٤.٠٠٨٦٥

IW5097137



Name: Hania Abass Abdalla

Date: 17/12/2025

Prof Dr Reda Megahed

Digital Mammography :

Accompanied by U/S

Rt breast

Irregular opacity extending all through the outer upper quadrant

No architectural distortion.

No microcalcification

Increased skin thickness with peu de orange appearance

Retracted disfigured nipple

No axillary lymphadenopathy.

Sonographic examination confirmed the radiological findings and display

9 o'clock hypo-echoic speculated lesion measuring 4.6 x 3.3 cm surrounded by interstitial edema and fibrotic changes extending in all outer quadrant

Most probably scirrhus carcinoma

BIRADS V

DR RABHA TAWFIK MD

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقق الشخصية



هنية

عباس سالم عفته

عزبة الشواربي

مركز القناطر الخيرية - القليوبية



٢٥٥.٥١٦١٤.٠٠٨٦٥

IW5097137

Nation ID - Front
ID000079510

٢٠٢١/٠٤ ٢٥٥.٥١٦١٤.٠٨٦٥
ربة منزل
أنثى مسلمة متروجة
سيد محمد ابوزيد عبدالرحيم
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٤/١٦ ١١



١١

Name: Hania Abass Abdalla

Date: 17/12/2025

Prof. Dr. Reda Megahed

Digital Mammography :**Accompanied by U/S****Rt breast**

ular opacity extending all through the outer upper
rant

chitectural distortion.

icrocalcification

ased skin thickness with peu de orange appearance

ected disfigured nipple

illary lymphadenopathy.

ographic examination confirmed the

ological findings and display

clock hypo-echoic speculated lesion

asuring 4.6 x 3.3 cm surrounded by

rstial edema and fibrotic changes

nding in all outer quadrant

t probably scirrhou carcinoma

ADS V

DR RABHA TAWFIK MD



Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روصي الدولي - مصر - مختبر أمراض



Patient Name	فنية عباس سالم	Case No.	357580
Sex/Age	Female 71 Y	Patient No.	25776
Registered Date	12/8/2026 09:39:54 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	19/9/2026 03:33:31 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	24/9/2026 09:06:28 AM	Pathology No.	2549/26

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 12/08/2026. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 1.0 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 2 (Differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- Ductal carcinoma in situ: Absent.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Mild.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 60%.

Patient Name	فنية عباس سالم	Case No.	357580
Sex/Age	Female 71 Y	Patient No.	25776
Registered Date	12/8/2026 09:39:54 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	19/9/2026 03:33:31 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	24/9/2026 09:06:28 AM	Pathology No.	2549/26

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).

- PR: Positive (score 8/8).

- Her2: Negative (score 0).

- Ki67%: 60%.

**Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

** Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within > 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature:

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.

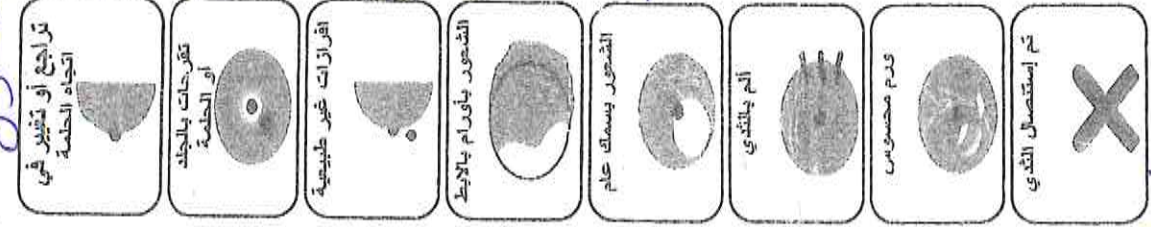
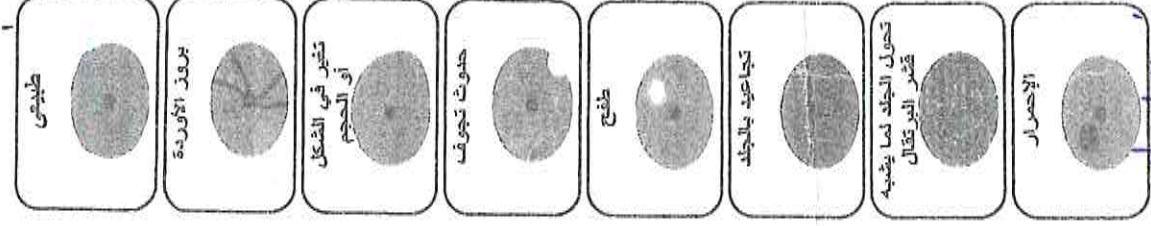
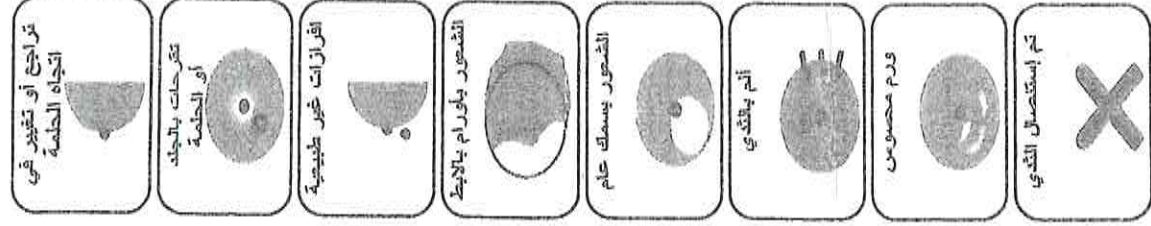
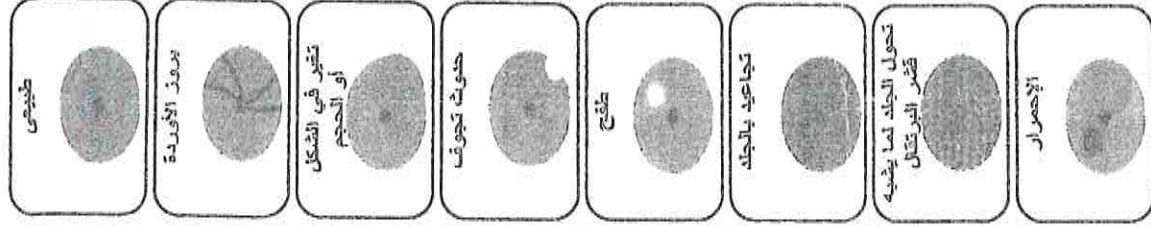
٢٠٠٥/٧/٢٠١٧

Advanced Clinical Exam

هليلج

الذي الأيسر

الذي الأيمن



Maximum mass dimension (mm):

Side:

- oRight
- oLeft
- oBilateral

Quadrant:

- oUOQ
- oUIQ
- oLOQ
- oLIQ

Central and retroareolar

Axilla

Imaging study requested:

- oSonography
- oMammosonography
- oMRI breasts

skin open

Plan d'exam

unilateral SM was done

f Bil Sonography

Patient's Name:

Hania Abbas Salem Afia

Date:

2026-08-12

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: right breast swollen with palpable lump

Findings:

left breast.

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- Evidence of axillary accessory breast.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Right breast.

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- Diffuse edema pattern of the whole breast in the form of thickened skin, coarsened trabeculae and diffusely increased density.
- Lower central, middle third, irregular speculated high-density mass lesion with no suspicious microcalcifications..
- **Ultrasound** demonstrated 3-9 o'clock, 1.5 cm from nipple, sub-cutaneous, irregular speculated heterogeneous hypoechoic solid mass lesion and mild internal vascularity on color Doppler study measuring 25 x 17 mm.
- Another similar lesion seen at 2 clock 23x24mm
- Thickened skin reaching 10 mm with interstitial and subdermal edema.
- Multiple (more than three) pathological axillary LNs are noted at levels 1, 2 & 3, all showing loss of fatty humlity largest measured 33 x 22 mm
- small pathological supra-clavicular lymph node 5x8mm.

Conclusion:-

- left breast (BIRADS 2): adenosis
- Right breast (BIRADS 5): Locaily advanced malignant process with ipsilateral pathological axillary lymph nodes.
- e.

Best Regards,

DR. Marwa M.Hassan

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقق الشخصية



هنية

عباس سالم عفته

عزبة الشواربي

مركز القناطر الخيرية - القليوبية



٢٥٥.٥١٦١٤.٠٠٨٦٥

IW5097137



Name: Hania Abass Abdalla

Date: 17/12/2025 Prof. Dr. Reda Megahed

Digital Mammography :

Accompanied by U/S

Rt breast

ular opacity extending all through the outer upper
rant

chitectural distortion.

icrocalcification

ased skin thickness with peu de orange appearance

ected disfigured nipple

illary lymphadenopathy.

ographic examination confirmed the

ological findings and display

clock hypo-echoic speculated lesion

asuring 4.6 x 3.3 cm surrounded by

rstial edema and fibrotic changes

nding in all outer quadrant

t probably scirrhou carcinoma

ADS V

DR RABHA TAWFIK MD

Patient Name	فنية عيسى سالم	Case No.	357580
Sex/Age	Female 71 Y	Patient No.	25776
Registered Date	12/8/2026 09:39:54 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	19/9/2026 03:33:31 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	24/9/2026 09:06:28 AM	Pathology No.	2549/26

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 12/08/2026. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 1.0 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
 - ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 2 (Differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- Ductal carcinoma in situ: Absent.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Mild.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 60%.

Patient Name	فنية عباس سالم	Case No.	357580
Sex/Age	Female 71 Y	Patient No.	25776
Registered Date	12/8/2026 09:39:54 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	19/9/2026 03:33:31 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	24/9/2026 09:06:28 AM	Pathology No.	2549/26

Conclusion:**Right breast mass, Tru-cut biopsy:**

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67%: 60%.

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within > 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature:

Dr. Walaa Ibrahim Chonaim, MD.

٢٠٠٥/٧/٢٠٠١٦٨

Advanced Clinical Exam

هليلج

الذي الأيسر

الذي الأيمن

طبيعي	تراجع أو تغيير في اتجاه الحلمة
بروز الأوردة	تقرحات بالجلد أو الحلمة
تغير في الشكل أو الحجم	أفرازات غير طبيعية
حذوث تجوف	الشعور بأورام بالابط
طفح	الشعور بسمك عام
تجاعيد بالجلد	ألم بالثدي
تحويل الجلد لما يشبه قشر البرتقال	ورم محسوس
الإحمرار	تم إستئصال الثدي

طبيعي	تراجع أو تغيير في اتجاه الحلمة
بروز الأوردة	تقرحات بالجلد أو الحلمة
تغير في الشكل أو الحجم	أفرازات غير طبيعية
حذوث تجوف	الشعور بأورام بالابط
طفح	الشعور بسمك عام
تجاعيد بالجلد	ألم بالثدي
تحويل الجلد لما يشبه قشر البرتقال	ورم محسوس
الإحمرار	تم إستئصال الثدي

طبيعي	تراجع أو تغيير في اتجاه الحلمة
بروز الأوردة	تقرحات بالجلد أو الحلمة
تغير في الشكل أو الحجم	أفرازات غير طبيعية
حذوث تجوف	الشعور بأورام بالابط
طفح	الشعور بسمك عام
تجاعيد بالجلد	ألم بالثدي
تحويل الجلد لما يشبه قشر البرتقال	ورم محسوس
الإحمرار	تم إستئصال الثدي

طبيعي	تراجع أو تغيير في اتجاه الحلمة
بروز الأوردة	تقرحات بالجلد أو الحلمة
تغير في الشكل أو الحجم	أفرازات غير طبيعية
حذوث تجوف	الشعور بأورام بالابط
طفح	الشعور بسمك عام
تجاعيد بالجلد	ألم بالثدي
تحويل الجلد لما يشبه قشر البرتقال	ورم محسوس
الإحمرار	تم إستئصال الثدي

Maximum mass dimension (mm):

Side:

- oRight
- oLeft
- oBilateral

Quadrant:

- oUOQ
- oUIQ
- oLOQ
- oLIQ

Central and retroareolar

Axilla

Imaging study requested:

- oSonography
- oMammosonography
- oMRI breasts

تحت المراقبة

skin open

Plan d'cong

underph sm was d

f Bil Sonography

Patient's Name: Hania Abbas Salem Afia

Date: 2026-08-12

Referred by: Prof.Dr. no doctor

Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: right breast swollen with palpable lump

Findings:

left breast.

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- Evidence of axillary accessory breast.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Right breast.

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- Diffuse edema pattern of the whole breast in the form of thickened skin, coarsened trabeculae and diffusely increased density.
- Lower central, middle third, irregular speculated high-density mass lesion with no suspicious microcalcifications..
- **Ultrasound** demonstrated 3-9 o'clock, 1.5 cm from nipple, sub-cutaneous, irregular speculated heterogeneous hypoechoic solid mass lesion and mild internal vascularity on color Doppler study measuring 25 x 17 mm.
- Another similar lesion seen at 2 clock 23x24mm
- Thickened skin reaching 10 mm with interstitial and subdermal edema.
- Multiple (more than three) pathological axillary LNs are noted at levels 1, 2 & 3, all showing loss of fatty humlity largest measured 33 x 22 mm
- small pathological supra-clavicular lymph node 5x8mm.

Conclusion:-

- left breast (BIRADS 2): adenosis
- Right breast (BIRADS 5): Locaily advanced malignant process with ipsilateral pathological axillary lymph nodes.
- e.

Best Regards,

DR. Marwa M.Hassan